



Guía Rápida GES

40. Síndrome de Dificultad Respiratoria en el Recién Nacido

Departamento GES de Redes Asistenciales

Control de Versiones

Versión	Fecha de Modificación	Descripción	Autor
1.0	06/06/2007	Descripción del problema de salud y su registro	Beatriz Heyermann Francisca Villarroel Liliana Vasallo Hsiao-Lan Sung
1.1	05/09/2007	Incorporación de criterios de cierre de caso para inasistencia	Lorena Labra
2.0	Abril 2013	Validación modificaciones al Decreto n° 4 del 2013	Beatriz Heyermann, Sidia Matus, Carlos Becerra, Cecilia Reyes, Leonardo Molina, Yonathan San Martín, Jeanette Toledo, Jessica Villena
2.1	Abril 2016	Modificaciones al Decreto N° 3 del 2016	Ana María Valencia, Patricia Kraemer, Marcela Cortés, Ana María Merello

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD	5
1.1 Decreto N° 3	5
<i>Definición:</i>	5
<i>Patologías Incorporadas:</i>	5
<i>a. Acceso:</i>	5
<i>b. Oportunidad</i>	5
<i>c. Protección Financiera:</i>	6
1.2 Ciclo de Atención	6
1.2.1 Descripción	6
1.2.2 Flujograma	8
2 REGISTRO SIGGES	9
2.1 Tabla Resumen	9

Introducción

Con la entrada en vigencia del **Decreto N° 03** del 27 de enero del 2016, se procura reforzar los conocimientos de quienes participan en el proceso de gestión, registro y monitoreo de la información que se extrae de los hitos relevantes del proceso de atención, incluyendo las particularidades de las GES.

El documento “Guía Rápida”, consta de los siguientes puntos:

1) Descripción del Problema de Salud

- **Decreto N° 03:** consistente en un extracto del decreto, que incluye la definición del problema de salud, las patologías incorporadas, las garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera. Teniendo como objeto de contextualizar el modelo GES para realizar el registro de información.
- **Ciclo de Atención:** corresponde al detalle de la operación en red establecida para atender a los pacientes en estos problemas de salud, según las definiciones y normativas del Ministerio de Salud. El cual tiene como finalidad guiar la aplicación del decreto ya conocido y su registro asociado. Esto se debe complementar con las definiciones de Flujos específicos locales adecuados al modelo de red de cada servicio, y a la definición de redes GES y no GES emitido por el MINSAL.

- 2) **Tabla Resumen:** detalla los hitos de atención a registrar en el SIGGES de acuerdo a las definiciones del decreto y del ciclo de atención, la cual está estructurada según las etapas de atención, las garantías de oportunidad y las intervenciones sanitarias correspondientes a este problema de salud, entregando de esta forma, los principales aspectos requeridos para el registro y monitoreo de la información relacionada a este problema de salud.

1 Descripción del Problema de Salud

1.1 Decreto N° 3

Definición:

Cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, cianosis, quejido y retracción subcostal.

Patologías Incorporadas:

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
- Bronconeumonía connatal
- Bronconeumonía no connatal
- Aspiración neonatal de meconio
- Hernia diafragmática congénita
- Hipertensión pulmonar persistente

a. Acceso:

Todo beneficiario recién nacido:

- Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar tratamiento.

b. Oportunidad

☐ **Diagnóstico y Tratamiento:**

- Inicio de tratamiento, desde la sospecha.
- Ingreso a prestador con capacidad de resolución integral: dentro de 72 horas, desde la sospecha.

c. Protección Financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
40.-	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO	Diagnóstico y Tratamiento	Enfermedad de la membrana hialina: confirmación y tratamiento	por tratamiento completo	6.764.100	20%	1.352.820
			Hernia diafragmática: confirmación y tratamiento	por tratamiento completo	4.723.140	20%	944.630
			Hernia diafragmática: tratamiento especializado con óxido nítrico	por tratamiento completo	6.147.710	20%	1.229.540
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	por tratamiento completo	4.879.570	20%	975.910
			Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	por tratamiento completo	4.495.430	20%	899.090
			Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	por tratamiento completo	2.800.830	20%	560.170
			Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	por tratamiento completo	1.747.110	20%	349.420

1.2 Ciclo de Atención

1.2.1 Descripción

Un recién nacido (entre 0 a 27 días) es evaluado por el profesional médico durante la hospitalización, quien sospecha un síndrome de dificultad respiratoria, iniciando el caso GES, e indicando el suministro de los tratamientos básicos, tales como: medidas generales, oxígeno y surfactante, en forma inmediata.

Una vez otorgado el tratamiento inicial, si el establecimiento no cuenta con la capacidad resolutoria requerida, debe derivar el paciente a uno con capacidad suficiente de acuerdo a la red, previa estabilización. Aun no se ha confirmado el caso, se encuentra en etapa de sospecha.

En caso de su confirmación, se continúa con el tratamiento correspondiente. De requerir ventilación de alta frecuencia o ventilación de alta frecuencia y óxido nítrico, el profesional tratante debe derivar al paciente al establecimiento definido según la organización de la red asistencial correspondiente.

Al finalizar el tratamiento correspondiente, de acuerdo a la indicación del profesional tratante, se puede dar por finalizada la atención.

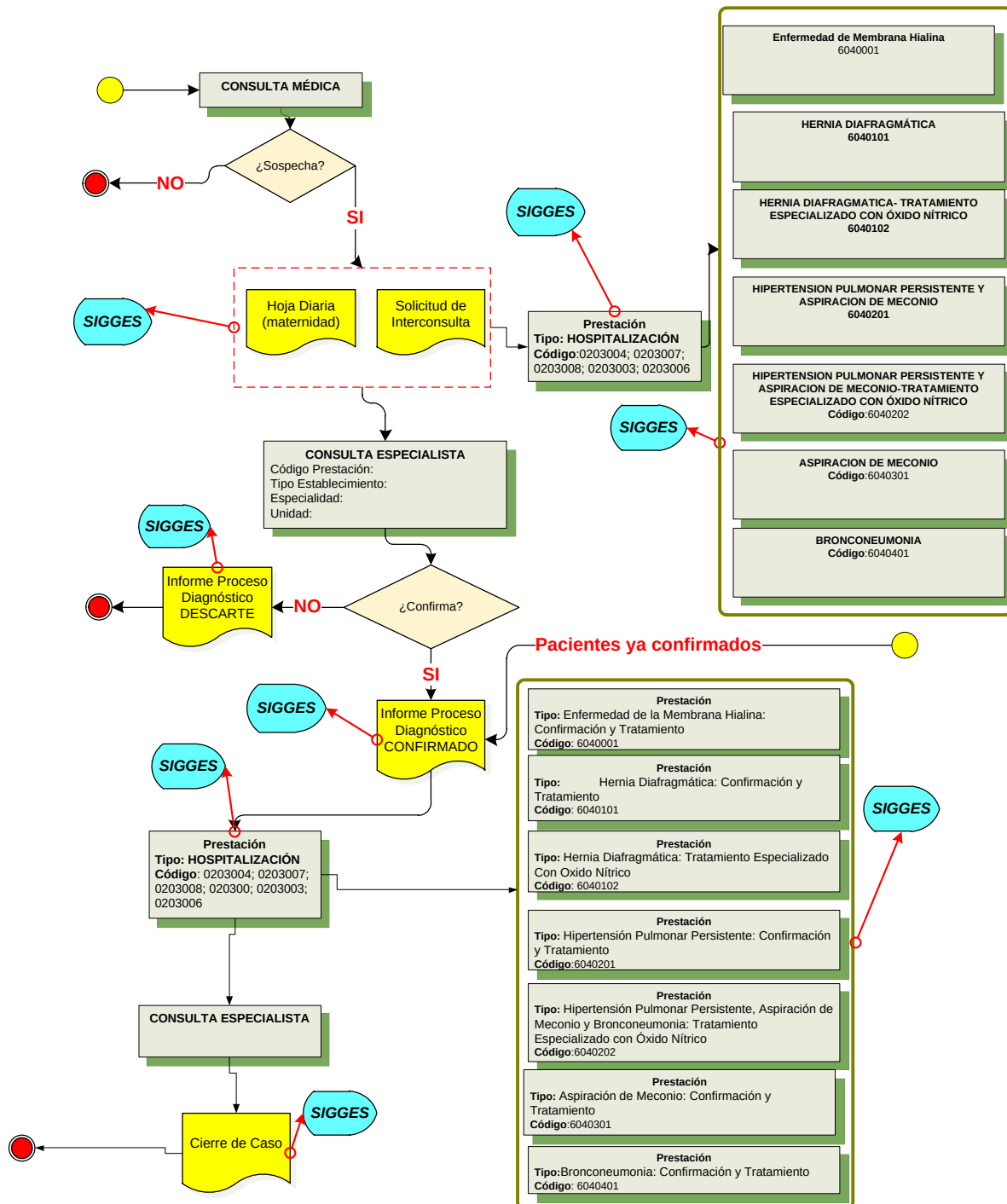
Cierre de casos: Se puede cerrar el caso GES asociado al paciente, ya sea por un médico o un administrativo según la causal de cierre que lo origine.

Las principales causales son:

- Fallecimiento
- Término de Tratamiento: por definición del médico tratante.
- Criterios de exclusión: cuando un paciente está siendo tratado como GES, por un problema de salud determinado, y durante el desarrollo del cuadro clínico el médico constata que el paciente no cumple con criterios de inclusión señalados en las guías clínicas.
- Término de tratamiento garantizado: cuando se ha cumplido en su totalidad el tratamiento que está garantizado en el decreto.
- Causas atribuibles al paciente:
 - Por rechazo al prestador
 - Por rechazo del tratamiento
 - Cambio de previsión
 - Otra causa expresada por el paciente
 - Inasistencia: Tres inasistencias a citaciones efectivas y registradas (revisar Norma Técnico Médico Administrativa vigente).

Frente al traslado definitivo del paciente (por cambio de domicilio) no corresponde efectuar cierre de caso, si no que un traslado interno entre establecimientos.

1.2.2 Flujograma



2 Registro SIGGES

2.1 Tabla Resumen

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Sospecha	El Médico ante sospecha solicita exámenes y deriva al paciente a un prestador capacidad de resolución integral	SIC y hoja diaria : derivación a especialidades 07-101-1: Neonatología 20-152: Neonatología Cuna 20-151: Neonatología Incubadoras 20-311: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatología 20-324: Unidad de Tratamiento Intermedio Neonatología Intermedia 20- 150: pediatría			X		Inicio de tratamiento desde sospecha	Establecimiento de origen de la SIC o de encabezado de hoja diaria	X	
							Ingreso a prestador con capacidad de resolución Integral dentro de 72 Horas desde la sospecha	Establecimiento destino de la SIC u OA	X	
Proceso diagnóstico	Médico de inicia tratamiento inmediato	PO: Tratamiento	Tratamiento	6040001: Enfermedad de la membrana Hialina. Confirmación y Tratamiento		X	Inicio de tratamiento desde sospecha			X
				6040101: Hernia Diafragmática: Confirmación y Tratamiento		X				
				6040102: Hernia Diafragmática: Tratamiento Especializado con Óxido Nítrico		X				

				6040201: Hipertensión Pulmonar Persistente y Aspiración de Meconio: Confirmación y Tratamiento		X				
				6040202: Hipertensión Pulmonar Persistente y Aspiración de Meconio: Tratamiento Especializado con óxido Nítrico		X				
				6040301: Aspiración de Meconio: Confirmación y Tratamiento		X				
				6040401: Bronconeumonía: confirmación y Tratamiento		X				
		PO: Hospitalización		0203004: Día Cama Hospitalización integral UTI o UCI Neonatal			Ingreso a prestador con capacidad de resolución Integral dentro de 72 Horas desde la sospecha			X
				0203007: Día Cama Hospitalización Integral Intermedia Neonatal						
				0203008: Día cama Hospitalización integral Incubadora						
				0203003 Día cama Pediatria Intensivo						
				0203006 día cama Pediatria Intermedio						

Confirmación	Médico Especialista nivel terciario confirma o descarta	IPD: confirma o descarta			X		Inicio de tratamiento desde sospecha (Ver Nota 1)	Establecimiento que emite el IPD	X	
Tratamiento	Médico Especialista Continúa con Tratamiento	PO: Tratamiento	Tratamiento	6040001: Enfermedad de la membrana Hialina. Confirmación y Tratamiento		X	Inicio de tratamiento desde sospecha			X
				6040101: Hernia Diafragmática: Confirmación y Tratamiento		X				
				6040102: Hernia Diafragmática: Tratamiento Especializado con Óxido Nítrico		X				
				6040201: Hipertensión Pulmonar Persistente y Aspiración de Meconio: Confirmación y Tratamiento		X				
				6040202: Hipertensión Pulmonar Persistente y Aspiración de Meconio: Tratamiento Especializado con óxido Nítrico		X				
				6040301: Aspiración de Meconio: Confirmación y Tratamiento		X				

		PO: hospitalización		6040401: Bronconeumonía: confirmación y Tratamiento		X				
				0203004: Día Cama Hospitalización integral UTI o UCI Neonatal						X
				0203007: Día Cama Hospitalización Integral Intermedia Neonatal						X
				0203008: Día cama Hospitalización integral Incubadora						X
				0203004: Día Cama Hospitalización integral UTI o UCI Neonatal						X
				0203003 Día cama Pediatría Intensivo						X
				0203006 día cama Pediatría Intermedio						x
Cierre de Caso	Médico da alta una vez que se termine el tratamiento	Formulario de Cierre			X					

Nota:Para aquellos pacientes que se ingresan como caso GES a partir de la confirmación diagnóstica.